| RSUD dr. LOEKMONO HADI<br>Sehat Anda, Senyum Kita<br>**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH**<br>**dr. LOEKMONO HADI**<br>Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus | **MATI BATANG OTAK (MBO)** | | |
|---|---|---|---|
| | No.Dokumen<br>400.7.3.4/815/2026 | No.Revisi<br>01 | Halaman :<br>1/2 |
| **STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL** | Tanggal terbit<br>5 Maret 2026 | Ditetapkan<br>Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi<br>Wakil Direktur Pelayanan<br><br>dr. MUSTIKO WIBOWO<br>Pembina Tk. I<br>NIP. 19820915 200903 1 004 | |

| | |
|---|---|
| PENGERTIAN | Keadaan terjadinya kerusakan permanen di batang otak dan seluruh otak. |
| TUJUAN | Sebagai acuan untuk menerapkan langkah – langkah dalam penanganan pasien yang membutuhkan RJP |
| KEBIJAKAN | Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi No. 03 Tahun 2026 Tentang Kebijakan Pelayanan |
| PROSEDUR | 1. Melakukan cuci tangan<br>2. Menjaga Privasi Pasien<br>3. Pastikan pasien tidak menggunakan obat-obatan pelumpuh otot<br>4. Memastikan arefleksia batang otak yang meliputi:<br>a. Tidak adanya respons terhadap cahaya<br>b. Tidak adanya refleks kornea<br>c. Tidak adanya refleks vestibulo-okular<br>d. Tidak adanya respons motorik dalam distribusi saraf kranial terhadap rangsang adekuat pada area simtomatik<br>e. Tidak ada refleks muntah (gag reflex) atau refleks batuk terhadap rangsang oleh kateter isap yang dimasukkan ke dalam trakea<br>5. Memastikan keadaan henti nafas yang menetap dengan cara:<br>a. Pre – oksigenisasi dengan O2 100% selama 10 |

| | |
|---|---|
| | menit;<br>b. Memastikan pco2 awal testing dalam batas 40-60 mmhg dengan memakai kapnograf dan atau analisis gas darah (AGD)<br>c. Melepaskan pasien dari ventilator, insuflasi trakea dengan O2 100%, 6 L/menit melalui kateter intra trakeal melewati karina<br>d. Observasi selama 10 menit, bila pasien tetap tidak bernapas, tes dinyatakan positif atau berarti henti napas telah menetap<br>6. Bila tes arefleksia batang otak dan tes henti napas sebagaimana dimaksud pada nomor 4 dan 5 dinyatakan positif, tes harus diulang sekali lagi dengan interval waktu 25 menit sampai 24 jam.<br>7. Bila tes ulangan tetap positif tidak ada reflek, pasien dinyatakan mati batang otak, walaupun jantung masih berdenyut.<br>8. Bila pada tes henti napas timbul aritmia jantung yang mengancam nyawa maka ventilator harus dipasang kembali sehingga tidak dapat dibuat diagnosis mati batang otak<br>9. Pemeriksaan harus dilakukan oleh 3 dokter yang kompeten yang harus melibatkan DPJP, Dokter Spesialis Anestesi dan Dokter Spesialis Syaraf |
| UNIT TERKAIT | Instalasi anestesiologi dan terapi Intensif |